

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準 Operating Standards to Prevent Patient Falls				
編號	A31000-Q02-W-H17	制定者	NI 謝慧君	公布日期	103 年 10 月 02 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 02 月 06 日
版本/總頁數	第 1.6 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員能針對兒科住院病人評估跌倒高危險群，給予適當的預防跌倒護理措施，減少跌倒發生及降低發生後的傷害程度，藉以提昇病人照護安全。

二、範圍

護理部兒科單位。

三、說明

（一）原則

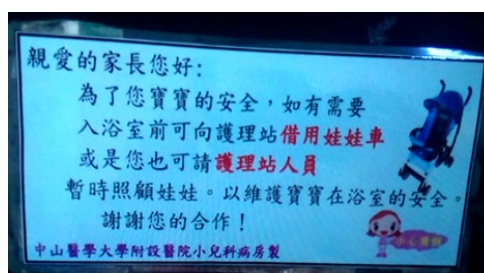
1. 兒科病人入院或轉入 8 小時內，依 HIS 系統工作清單之「跌倒危險因子評估表」，評估是否為高危險群，並擬定預防高危險群跌倒措施，若總分 ≥ 4 分需加強跌倒預防衛教，於病床床頭放置預防跌倒的標誌，並為病人戴上粉紅色手圈，詢問是否需更換為兒科小鐵床，若總分 ≥ 6 分需列為護理問題-易跌倒，每班至少紀錄一次。
2. 針對病人個別性、安全環境的維護及藥物調整提供適當的護理措施。
3. 再評估時機：每週定期評值或遇病人轉入、病情改變或有發生跌倒時。
4. 定期執行病人預防跌倒之安全宣導。
5. 針對護理人員在病人跌倒預防部份，進行不定期稽核。
6. 病人入院或轉入 8 小時內、病情改變（意識、肢體活動改變、發生跌倒、全麻手術後）由負責護理人員登入 HIS 系統跌倒危險因子評估進行評估，若無上述情況，則依評值原則每週定期評值。

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	2/11

(二) 預防跌倒護理措施分為病人照護、安全環境維護及藥物調整部份。

1. 病人照護：

- (1) 衛教病人及照顧者，病人目前是跌倒高危險群，並掛「預防跌倒」之床頭牌及佩戴粉紅色手圈，提醒所有人員提高警覺。
- (2) 衛教病人及照顧者，病人住院期間須有照顧者 24 小時陪伴在旁，若照顧者要離開病房時，必須確認床欄是否拉起，並告知護理人員且時間不宜過久，以預防意外發生。
- (3) 衛教照顧者，兒童病床床欄正確使用方式並有圖示張貼於醫療牆上，病人於床上時，請隨時將兩側床欄拉起至最高並固定，床欄杆若縫隙太大，可用硬枕頭或棉被堵住以防跌落，床體高度平時維持在最低位置，床輪於靜止狀態應予固定，避免滑動，若需下床時，應先將床欄放下勿翻越。
- (4) 衛教照顧者，避免將 3 歲以下的病人放置於陪客床或無扶把的椅子上，避免讓病人站於棉被、枕頭及床上嬉戲或跳躍及搖晃床欄，攀拿物品，且不要在床上放置太多的東西，應將床單保持平整，以減少病人跌落。
- (5) 衛教照顧者，應將常用物品放置於病人視線內且易拿取之範圍，或使用小的玩具，才不致於利用玩具而爬出翻落，另外照顧者轉身取物離開視線範圍，例如：轉身泡牛奶、拿東西及如廁等，請務必將床欄拉起，以免病人跌落。
- (6) 衛教照顧者，病人若如廁所或沐浴時，應先將用物準備齊全後，再協助病人至浴廁，以免照顧者離開拿取用物時，造成病人跌倒；提醒照顧者需如廁或沐浴，為了您寶寶安全於入浴室前可向兒科病房護理站借用娃娃車或是您也可請護理站人員暫時照顧娃娃，期能妥善安置病兒，確保病兒父母如廁時之病兒安全。



主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	3/11

- (7)衛教病人及照顧者，病人若下床進行活動時，應有人陪伴並於左右側協助扶持，若病人有虛弱、下床步伐不穩、視力模糊、意識不清、血壓低、血糖低及頭暈或使用鎮定劑之病況，護理人員應教導姿勢性低血壓的預防，轉換姿勢或下床時，應採漸進式活動的方式，例如：下床時請先坐在床緣休息片刻，無不適時再由家屬陪同下床。
- (8)衛教照顧者使用輔具時應確定輪子已固定才可活動，使用嬰兒車時，應避免讓病人站立於嬰兒車上，並繫上安全帶，使用輪椅時，應先將輪椅完全打開，並拉起腳踏板，固定好煞車輪後，才將病人攙扶到輪椅上，若病人坐姿不穩可以用床單固定在輪椅上，以防跌落，使用點滴架時，應注意點滴管路長度勿讓病人站在點滴架上滑行，避免病人抓握不穩或點滴架翻倒而跌倒。
- (9)衛教照顧者應注意病人的衣褲是否太大，必要時予摺起固定，鞋子是否合腳且應穿防滑鞋或堅固平穩的鞋子，不可以打赤腳或穿平滑的鞋底，避免滑倒。
- (10)早產兒、新生兒或出生四個月內之嬰兒需使用嬰兒保溫箱或嬰兒處理台時，護理人員離開或轉身取物時需確實關閉保溫箱門並卡榫，避免病嬰掉落。
- (11)對於躁動不安、意識不清高危險群跌倒病人，其床欄應隨時拉起，必要時與醫師討論評估後，經醫師跟家屬解釋，由家屬同意並簽署身體約束同意書，再依醫囑給予適當的保護性約束，護理人員每班需評估是否仍須給予保護性約束，且每天需與醫師討論及評估是否需撤除保護性約束。
- (12)除了行進中的輪椅外，未使用一定要先固定，避免突然滑動，造成意外發生。

2. 安全環境維護：

- (1) 兒科病人儘可能使用兒科小鐵床。
- (2) 叫人鈴應放置於病人伸手可及之處，並確認病人能正確使用叫人鈴。
- (3) 高危險群病人需增加探視的次數，每隔 1-2 小時或依醫囑巡視病人，並主動協助高危險病人之基本生理需要，如：大小便、進食及盥洗等。

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	4/11

- (4)注意環境照明，病房內應隨時保持室內光線充足，非休息時間，請將病室內的窗簾及隔簾拉開，以增加能見度，夜間請保留床頭燈及浴廁燈，以利照明，若有損壞的燈管或功能不佳的燈管，立即請工務組維修。
- (5)檢修病房床欄、叫人鈴、活動點滴架、陪客床、椅子、保溫箱門卡榫及輪子有無損壞情形，若有損壞，則立即請修。
- (6)病人物品儘量收於櫃內，保持走道通暢、寬敞及避免地板表面雜亂，防止病人不慎絆倒。
- (7)病房地面應平坦，地面若有破損或其他障礙物，應盡速修復或排除，如地面潮濕及積水應立即通知護理人員請清潔人員處理，且擺放地面未乾之警示牌，協助維護病室地面乾燥。
- (8)浴室內應隨時保持乾燥或穿止滑拖鞋，且設有扶手設備及廁所紅燈供病人使用。
- (9)清潔人員洗地或拖地時，應告知走道要先洗（拖）一邊待地面乾燥後，再洗（拖）另一邊地板，此外洗（拖）地前應先告知病人或家屬。
- (10)走廊及樓梯，應設置扶手或欄杆，且避免讓病人在走廊及病房內追逐嬉戲。
- (11)給予衛教單張並依個別性說明。

3. 藥物調整部份：

- (1)加強護理人員對容易造成跌倒藥物副作用的認知，並衛教照顧者，若服用鎮靜/止痛/安眠/利尿/降血壓/降血糖等藥物，易導致跌倒，應特別注意盡量減少下床。
- (2)護理人員於病人住院第一次時，衛教容易造成跌倒藥物，並詳加說明藥物可能的作用及注意事項，且於護理紀錄上需確實記載給藥前衛教內容及藥物使用後病人狀況，夜班護理人員主動提醒或協助病人臨睡前如廁之需求。
- (3)病人若因服用藥物造成步態不穩或跌倒，應立即與醫師討論是否調整藥物。

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	5/11

（三）發生跌倒後評估及護理措施：

1. 跌倒後 24 小時內密切觀察病人生命徵象及意識形態的變化，以早期發現延遲性的傷害，如：顱內出血或出血等。
2. 傷口護理：依據「護理部_A31000-Q05-W-B41_傷口換藥法」予以護理。
3. 肌肉骨骼損傷護理：急性挫傷或拉傷 24 小時內，依醫囑給予彈性繃帶固定及冰敷減少腫脹；若 X 光檢查發現有脫位或骨折，協助醫師給予夾板或石膏固定，需每班觀察末梢血循。
4. 疼痛評估：評估疼痛性質後確定疼痛引發原因，必要時依醫囑給予病人止痛藥物，或協助採舒適臥位。
5. 護理記錄：在護理記錄上詳細記錄跌倒後評估的結果，包括生命徵象、傷口特徵、疼痛的部位及性質，跌倒後所引發的問題及因應措施。
6. 24 小時內通報病安，護理人員至 HIS 系統/程式集/異常事件通報系統/異常事件通報或至院內網站/入口網站/登入帳號密碼/異常事件通報系統/異常事件通報，將跌倒發生經過及處理依序完成點選及說明，並告知護理長、當班組長或值勤護理主管。

項 目	流程說明	備 註
入院或轉入	8 小時內依 HIS 系統工作清單之「跌倒危險因子評估表」進行評估。	※跌倒定義：病人因意外跌落至地面或其它平面
收案	當病人評估結果總分 ≥ 4 分，則擬定預防高危險群跌倒措施，於病房中標示預防跌倒的標誌，並為病人戴上粉紅色手圈。	
措施	分為病人照護、安全環境維護及藥物調整。	
定期評值及追蹤	1. 每週定期評值或病情改變時重評。 2. 當病人轉入或發生跌倒時應重評。	
結案	記錄於護理紀錄，轉院、自動出院、expired。	

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

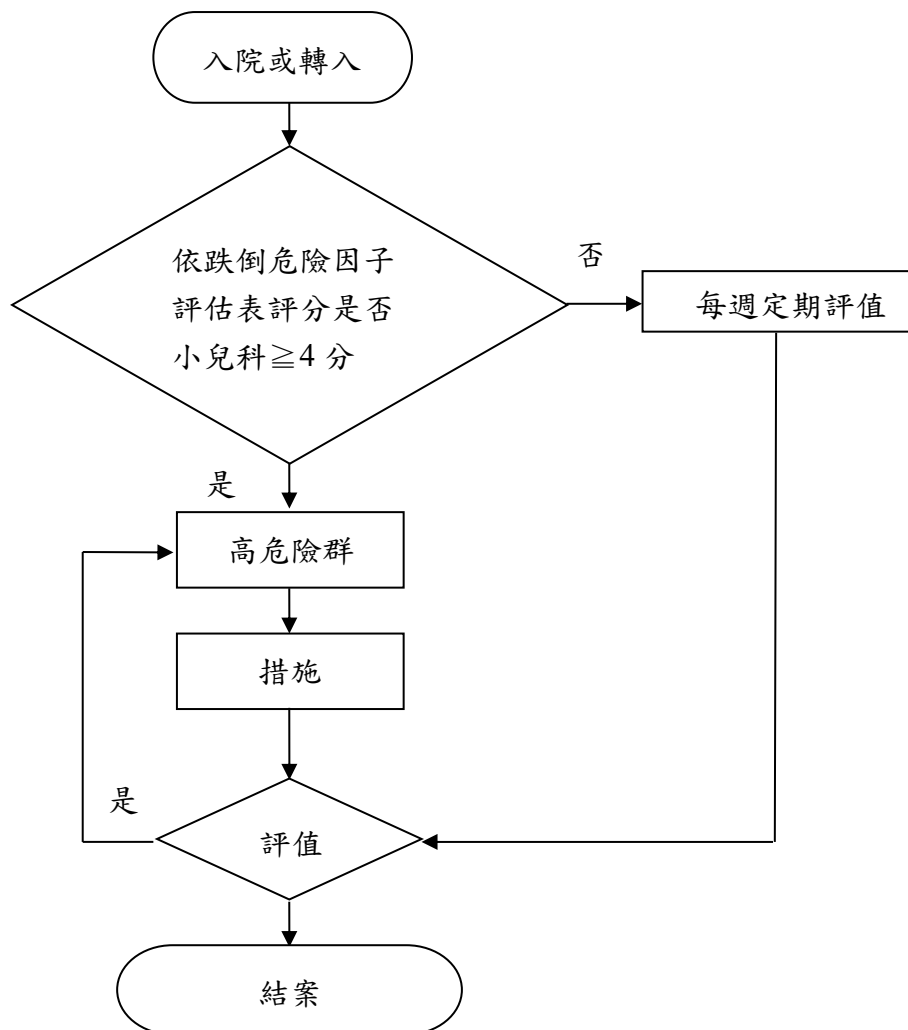
主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	6/11

四、使用表單

（一）跌倒危險因子評估表——小兒科。

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	7/11

五、流程圖



主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	8/11

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	9/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
103.10.02	1.0	新制定	103 年 10 月 02 日護理部照護標準委員會通過；103 年 10 月 02 日公布
104.10.06	1.1	第三項說明內容部份修辭	104 年 10 月 06 日護理部照護標準委員會通過
104.12.01	1.2	新增第三項第(二)目之 1(12)內容：除了行進中的輪椅外，未使用一定要固定，避免突然滑動，造成意外發生。	依據異常事件通報案號：AB10410001 提出修正，於 104 年 12 月 01 日護理部照護標準委員會通過
105.10.04	1.3	1. 第三項第(二)目之 1(3)新增：兒童病床床欄正確使用方式並有圖示張貼於醫療牆上。 2. 第三項第(二)目之 1(6)新增說明：提醒照顧者需如廁或沐浴，為了您寶寶安全於入浴室前可向兒科病房護理站借用娃娃車或是您也可請護理站人員暫時照顧娃娃，期能妥善安置病兒，確保病兒父母如廁時之病兒安全。	105 年 10 月 04 日護理部照護標準委員會通過
106.04.19	1.4	1. 第三項第(一)目之 6 新增：病人入院或轉入 8 小時內、病情改變（意識、肢體活動改變、發生跌倒、全麻手術後）由負責護理人員登入 HIS 系統跌倒危險因子評估進行評估，若無上述情況，則依評值原則每週定期評值。 2. 因表單已資訊化故刪除附件跌倒危險因子評估表—小兒科。	106 年 04 月 19 日護理長週會決議通過
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	1.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 10 月 03 日照護標準組會議通過；108 年 10 月 09 日護理長會議通過；108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	10/11

修正日期	版本	修正說明	備註
109.10.08	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.10.06	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.26	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.08	1.6	第三項第(一)目第一點：刪除:高危險性傷害/ 新增:易跌倒	114 年 02 月 06 日照護標準組會議通過；114 年 03 月 12 日護理長會議通過；114 年 04 月 08 日督導會議通過公布
114.10.02	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	預防兒科病人跌倒作業標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-H17	版本	第 1.6 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註